



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : سحر عبد الفتاح عبد اللاه جمال الدين

العنوان : شارع صلاح الدين -
زفتى غريبه

الحي / المدينة : زفتى

المحافظة : الغربية

تاريخ تسجيل الإستمارة : 07-10-2026

رقم البطاقة : 27205151601904 رقم التليفون : 01225734281

العمر (تاريخ الميلاد) : 15-05-1972 المهنة : حاصل علي دبلوم

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني مثبتات الاروماتيز [14161]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... /د. /د. /د. /د. /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :
قسم :
نفقات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: سحر عبد الفتاح عبد اللاه جمال الدين National ID: 2720515160I904	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Second Line Hormonal Treatment Aromatase Inhibitor

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



MS
مسعود
فد عيسى



01225734221

CVC-01017-19-2

Name	Phur Chhime, son
Age	29
MARN	EC051001
ID	
Co-morbidity	medically free



RT breast is ~~simple~~ simple
 RT breast is ~~simple~~ simple

Bx

Diagnosis: <u>DCIS & focal micro-invasive</u>	SM:
IHC: ER: +ve (100%) PR: +ve (100%) Her2: +ve (3+) Ki67: +ve (3+)	Mets Workup:

T N M

PT1a N0

Brst simple

RT simple Mastectomy

COMMENT:
 - Specimen Pathology -> IDC 6 II with
 - major High p to a l.v -> (0/6) SINB
 - Deep margin free

Bone Scan: 5/11/2021: Free
 CT 12/2021: Free
 ECHO 7/4/

MDT OUTCOME & PLAN

30/10/2021

- simple Mastectomy -> PT1a N0
 - for 5 yrs am. - 4 recept
 - No need for adjuvant therapy

(M) 11/10/21

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
<u>(M) 11/10/21</u>	<u>(M) 11/10/21</u>	<u>Moula</u>	

Name: سحر عبدالفتاح عبد الاله جمال الدين			
MR. : 5578			
Detailed Medical Report			
		السيد	
تحتية طبية وبعد,,			
		إيماء للطلب المقدم من	
بشأن تقرير طبي للمريض			
رقم طبي:		بقسم:	
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته			
تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه			
The patient presents for a routine visit on 02/06/2026, during which the oncology team initiated supportive therapy with Aramidex 1 mg and scheduled a new assessment including breast ultrasound and bone scan. On 30/07/2026, the anesthesia team documented the patient's status as having non-metastatic breast cancer with neuropathic pain, and prescribed gabapentin 300 mg once daily in addition to paracetamol 1000 mg every 8 hours for pain control. On 12/08/2026, the oncology team noted that the patient is receiving Arimidex and supportive care, with a planned 3-month course of bone scan follow-up; the breast ultrasound remains pending.			
تحريراً في ,			
التاريخ :		20-09-2026	
الوقت :		ندى على محمد اسماعيل	
الطبيب المعالج :			
يعتمد ,			

Patient Name: Sahar Abe Al Fattah Abd Ellaah Gamal Al Din	Date : 27/03/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 52 Year(s)
Medical ID: 4253/2021	Pat. ID: 18224

LEFT BREAST MAMMOGRAPHY WITH BILATERAL US

Technique

- LEFT breast MLO and CC views
- Bilateral ultrasound

Findings

- The left breast is predominant fatty densities of the right breast (ACR a)
- No spiculated masses or grouped microcalcifications.
- Complementary ultrasound also showed no left breast solid or cystic masses
- Normal skin thickness and nipple-areolar complex, with average caliber of the retro-areolar ducts
- Non-specific left axillary LN, with preserved fatty hilum and uniform cortical thickness.
- Free right operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- Free right supra and infra regions

Conclusion

- Right ABIM with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- No left breast suspicious findings (BIRADS 2)

Best regards,
Dr/Asmaa Zeinhom, MSc

Not Approved

Patient Name	: الأستاذة / ممر عبدالفتاح عبداللّاه جميل الدين	Request No.	: 133524
Patient No.	: 27205151601904	Request Date	: 20/12/2021
Path No.	: SR-743/21	Verification Date	: 28/12/2021
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 49 Y	Department	: Out Patient
Referring Doctor		IHC No.	:

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data:
Right breast mass

Nature of the specimen:
Slide revision

Gross Examination:
10 block (6414/21) & 2 blocks (5770) & 5 slides

Microscopic examination:
• Histological type:
1- Tru-Cut lymph node biopsy: Reactive hyperplasia
2- Tru-Cut breast biopsy: DCIS
3- MRM specimen: Focal microinvasion & major DCIS with extensive lobular cancerization.
• Angiolysis: No
• Lymph node involvement: All examined lymph nodes are free (0/6)

Diagnosis:
Right breast mass; Slide revision:
1- Tru-Cut lymph node biopsy: Reactive hyperplasia
2- Tru-Cut breast biopsy: DCIS
3- MRM specimen: Focal microinvasion & major DCIS with extensive lobular cancerization.
All examined lymph nodes are free (0/6)

IHC:
ER: No nuclear reaction in tumour cells. Negative, score (0/8)
PR: Weak nuclear reaction in 15% of tumour cells. Positive, score (3/8)
Her-2: Strong complete membrane reaction in 10% of tumour cells. Positive, score 3+

Prof. Dr. Amal Hareedy
Dr. Abdulrahman Ibrahim



Patient Name : الأستلاء / بحر عبدالفتاح عبداللہ جمال الدين	Request No. : 13008395
Patient No. : 27205151601904	Request Date : 11/01/2024
Patient No. : 164/24	Verification Date : 23/01/2024
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - برامج ناز السلام
Age : 51 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youse

Pathology Report

Clinical Data

Thick endometrium

Nature of specimen

D&C

Gross specimen

Mucosa hemorrhagic fragmented curette collectively 1x1 cm, totally submitted

Microscopic examination

Examination revealed multiple fragments of endometrial tissue formed of crowded irregular focally dilated glands lined by columnar cells with pseudostratified nuclei within spindle stroma, focally fibrous entangling thick walled blood vessels denoting polyp formation, no evident atypia

Diagnosis

Thick endometrium, D&C

Endometrial hyperplasia with polyp formation, No atypia

Signature

Dr.Rana Fathy

Dr.Heba Hassan

Verified by :

Dr.Heba Hasan

Printing Date : 19-02-2024 10:41:51

Page 1 of 1

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy